

UKEゴールデンテスト用：支払基金「電子レセプトの作成手引き－歯科－」記録例 インデックス & 出力検証ツール調査

結論（保存先：[docs/specs/uke-examples-index.md](#)）：参照すべき記録例の本体は支払基金が公開する単一PDF [jiki_s01.pdf](#)（「電子レセプトの作成手引き－歯科－ 令和6年9月版」、約3,525KB）であり、UKE形式のCSV記録例は同PDFの各章「3 ○○レコード記録例」と「第14部 入院外レセプトの記録例（p79～）」に集中している。ゴールデンテストの検証条件は「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科） 令和6年11月版」と「同チェックロジック（歯科） 令和6年7月版」で機械可読的に把握でき、出力検証の実環境としては支払基金オンライン請求システムの「受付・事務点検ASP」と「レセプトデータの確認試験」が使える。

TL;DR

- 最新版は「電子レセプトの作成手引き－歯科－ 令和6年9月版」、PDF直リンクは https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/iryokikan_02.files/jiki_s01.pdf（約3,525KB、単一PDF・分冊なし）。掲載ページは「電子レセプトの作成 | 社会保険診療報酬支払基金」（[iryokikan_02.html](#)）。医科=[jiki_i01](#) / DPC=[jiki_d01](#) / 調剤=[jiki_t01](#) / 訪問看護=[jiki_h01](#) と区別され、**歯科は [jiki_s01.pdf](#) のみ**。
- 記録例の所在は目次から特定済み：初診 p79、X線・検査 p87/p102、処置・手術（識別41～44） p104～116、歯冠修復・欠損補綴（識別61～64） p117～129、公費レコード記録例 p16～17。HS（傷病名部位＝歯科は識別子「**HS**」、医科のSYとは異なる）の歯式記録は第8部 p22～37、SS（歯科診療行為）の数量・点数は第9部 p38～45。
- 出力検証ツールは支払基金の「受付・事務点検ASP」＋「レセプトデータの確認試験」が本命。判定内容は無償公開の「チェック一覧（歯科）」「チェックロジック（歯科）」で確認でき、テストデータは支払基金が「令和6年6月診療分 歯科:16件（ZIP:754KB）」のサンプルを配布。[Ssk](#) ORCA（日医標準レセプトソフト、オープンソース）がレセ電出力の参照実装になりうる。

重要な版の注意（要確認）：手引き本体（令和6年9月版）は冒頭凡例で「『オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（歯科用）（令和6年4月版）』に基づく記録方法を示したもの」[Ssk](#) [ssk](#) と明記している。一方ユーザーが保有する記録条件仕様は令和8年6月版。掲載ページでも記録条件仕様・標準仕様は令和8年6月版が最新として案内されている。[ssk](#) したがって手引きの記録例は令和6年4月仕様ベースであり、令和8年6月仕様で追加・変更された項目（例：資格確認・枝番まわり等）はこの手引きには反映されていない可能性がある。ゴールデンテストの「正」は記録条件仕様（令和8年6月版）側を優先し、手引きは記録パターンの例示として使うこと。

1. ダウンロードすべきPDF一覧表（まずこれを揃える）

#	資料名	版	ファイル名 / 直リンクURL	用途
1	電子レセプトの作成手引き－歯科－	令和6年9月版	jiki_s01.pdf / https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/iryokikan_02.files/jiki_s01.pdf （約3,525KB）	記録例の本体。最優先
1'	（掲載ページ）電子レセプトの作成	－	https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/iryokikan_02.html	上記PDFのリンク元。版確認に使う
2	受付・事務点検ASPに係るチェック	令和6年11月	checkichiran_shika.pdf / https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/download/index.files/checkichiran_shika.pdf	出力が満たすべき検証条件（エラー

	クー覧 (歯 科)	版		メッ セー ジ一 覧)
3	受付・ 事務点 検 ASP に係る チェッ クロ ジック (歯 科)	令和 6年 7月 版	checklogic_shika.pdf / https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/iryokikan/download/index.files/checklogic_shika.pdf	チェッ クの判 定口 ジック 詳細 (レ コード 順序・ 項目別 チェッ ク)
4	レセ電 コード 情報 ファイル 記録 条件仕 様(歯 科)	令和 6年 6月 版 (※ 掲載 ペー ジで は令 和8 年6 月版 が最 新案 内、 要確 認)	rezeptl1.pdf / https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/hokenja/download/index.files/rezeptl1.pdf (約 1,037KB)	レコー ド仕様 の補完 (保険 者向け 配信形 式)

掲載ページ内訳（参考、iryokikan_02.html）：医科 jiki_i01.pdf（2,299KB）／DPC jiki_d01.pdf（2,439KB）／歯科 **jiki_s01.pdf（3,525KB）**／調剤 jiki_t01.pdf（3,607KB）／訪問看護 jiki_h01.pdf（令和6年6月版・3,737KB）。分冊構成はなく、歯科は単一PDF。

2. 手引きの記録例所在インデックス（目次ベース／PDFページ番号）

手引き本体（jiki_s01.pdf）の目次は4分割（目次1/4～4/4）。記録例（CSVのレコード行実例）は、各レコード章の「3 ○○レコード記録例」節と、診療行為をまとめた**第14部「入院外レセプトの記録例」（p79～131）**に集中する。以下はPDF目次から特定したページ番号（PDFビューア上のページではなく手引きの本文ノンブル）。

2-1. レコード単位の記録例

章・部	記録例の節	ページ
第1章 受付情報	3 受付情報レコード記録例	p2
第2章第1部 医療機関情報	3 医療機関情報レコード記録例	p4
第2部 レセプト共通	3 レセプト共通レコード記録例	p9
第3部 保険者	3 保険者レコード記録例	p14
第4部 公費	3 公費レコード記録例 / 4 公費併用に係る記録順	p16 / p17
第5部 資格確認	3 資格確認レコードの記録例	p19
第6部 受診日等	3 受診日等レコードの記録例	p20

第7部 窓口負担額	3 窓口負担額レコードの記録例	p21
第8部 傷病名部位	3 入院外レセプト表示について / 4 入院外レセプト傷病名部位レコード記録例	p25 / p27
第9部 歯科診療行為	1 フォーマット / 2 項目 / 3 加算の記録順及び点数計算	p38 / p38 / p43
第3章 診療報酬請求書情報	3 診療報酬請求書レコード記録例	p139

2-2. 第14部「入院外レセプトの記録例」（診療識別別、p79～131）

記録例	診療識別コード	ページ
(1) 初診	11	p79
(2) 再診	12	p81
(3) 管理・リハ	13	p83
(4) 投薬・注射	21	p85
(5) X線・検査（X線：単純/特殊/歯科用3次元/造影 等）	31	p87～101
(6) X線・検査（検査）	31	p102
(7) 処置・手術1～（その他）	41～44	p104～116
(8) 麻酔	54	p116
(9) 歯冠修復及び欠損補綴1～（その他）	61～64	p117～129
(10) 全体のその他	80	p130
(11) 摘要	99	p131

2-3. 症例タイプ別の所在マップ（ユーザー指定の4ケース）

レコード行自体は転記せず、「どのページに何があるか」と「使われるレコード種別の並び」のみ示す。

- **(a) 初診＋充填などの単純症例**：初診=第14部(1) **p79** ＋ 充填等の歯冠修復=第14部(9)ア（識別61） **p117**。典型レコード構成 UK → IR → RE → HO → （必要時 SN）→ HS → SS → （必要時 CO）→ GO。患者属性：医保・入院外（手引きの表示例は特記なき限り入院外、凡例6）。

ssk
- **(b) 歯周治療（歯周検査・SC・SRP等）を含む症例**：歯周病検査=第14部(6)検査 **p102**、SC・SRP・歯周基本治療等=第14部(7)処置・手術 **p104**～。歯式（対象歯）は傷病名側はHS、診療行為に紐づく歯式は**CO**レコードで表現（後述§3）。構成 ...→ HS（歯式付）→ SS（処置）→ CO（歯式コード）→...。
- **(c) 補綴（クラウン・ブリッジ・義歯）を含む症例**：第14部(9)歯冠修復及び欠損補綴 **p117～129**（修復・補綴1=61 p117／2=62 p120／3=63 p124／その他=64 p128）。使用材料は**TO（特定器材）**を併用。構成 ...→ SS（補綴）→ TO（特定器材）→ CO →...。
- **(d) 公費併用レセプト**：公費レコード記録例=第4部 **p16**、公費負担医療併用に係る公費レコードの記録順=**p17**。構成は保険者レコード HO に続けて KO（公費）を法別番号順に複数記録。負担区分の記録は第14部(2) **p68**を参照。

3. 記録の留意事項の所在（HS部位記録／SS数量・点数）

3-1. HS（傷病名部位レコード）の歯式・部位記録 — 第8部 p22～37

- レコード識別子は歯科では「HS」（医科の傷病名レコード「SY」とは別。これはゴールドデンテストの分岐で要注意）。
- 歯式コードは**「歯種コード4桁＋状態コード1桁＋部分コード1桁＝計6桁」**で1歯を表し、HSレコードの「歯式コード（傷病名）」「歯式コード（補足コメント）」項目に記録。**最大64個（=384バイト、6の倍数）**まで連記。

Ssk

- **配列順の留意事項**（記録条件仕様の注記＝手引きも同準拠）：複数歯は「右上遠心→右上近心→左上近心→左上遠心→右下遠心→右下近心→左下近心→左下遠心」の順。乳歯・過剰歯が永久歯と同部位に並存する場合は2つの歯式を同じ配列順で並記。ssk ブロック単位を表す特別な歯式コードは単独（6桁のみ）で記録。
- HSレコードは診療開始日の昇順で記録。Ssk 要点・表示ルールは第8部「3 入院外レセプト表示について」p25。

3-2. SS（歯科診療行為レコード）の数量・点数記録 — 第9部 p38～45 + 第14部 p65～78

- SSレコードの項目構成（記録条件仕様準拠）：レコード識別情報(SS) / 診療識別 / 負担区分 / 診療行為コード / 診療行為数量データ1・2 / 加算コード1～35+各加算数量データ / 点数 / 回数 / 算定日情報(1～31日)。
- 歯科の加算は医科と異なり、加算先と同一レコード内の「加算コード1～35」に注加算・通則加算・基本加算・材料1加算・材料2加算の順で記録（医科のように別レコードにしない）。記録順と点数計算は第9部「3 加算の記録順及び点数計算」p43。
- 数量データは歯科診療行為マスター・基本テーブルの「きざみテーブル関連識別」に1/2が設定された行為に整数で記録。
- 共通記録方法（複数レコードにまたがる留意）は第14部「1 各レコード項目の記録」：診療識別の記録 p65、負担区分の記録 p68、点数の記録 p70、レセプト表示方法 p71～78。
- **SSレコードには歯式コード項目は存在しない**。診療行為に紐づく歯式が必要な場合は**COレコード（歯式コード（コメント）、最大64個・6の倍数バイト）**で表現する設計。これは出力エンジン実装で間違えやすいポイント。

補足（要確認）：上記の項目順・加算の同一レコード内記録・歯式の格納先（HS/CO）は記録条件仕様（歯科用）に基づく確定情報。ただし別表15～17（歯種/状態/部分コード）は現行仕様で「削除」となっており、歯式は「別に定める歯式コード（1コード6バイト）」に一本化されているとの調査結果がある。歯式コードの最新の定義は**マスターファイル仕様説明書（歯式マスター）と記録条件仕様（令和8年6月版）**で必ず突き合わせることを。

4. UKE出力検証ツール（ゴールドンテストの補完・代替）

4-1. 支払基金「受付・事務点検ASP」（本命）

- オンライン請求システム内で、請求確定前にレセプトデータを送信して事務点検チェックを受けられる機能。「ASPあり」で送信するとエラーが返り、当月内（12日まで）に修正・再請求できる。
- チェック内容を公開資料から把握できるのがゴールドンテスト設計上の価値：
 - 形式・コード存在・記録順序・レコード間関連のチェックロジックは「受付・事務点検ASPに係るチェックロジック（歯科）令和6年7月版」（[checklogic_shika.pdf](#)）に「第2 基本チェック」「第3 項目別チェック（受付情報/医療機関情報/レセプト共通/保険者/公費/資格確認/受診日等/窓口負担額/傷病名部位...）」Ssk として記載。
 - 個別エラーと受付不能/要確認の区分は「受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科）令和6年11月版」（[checkichiran_shika.pdf](#)）。エラーコード体系：L1（1000番台＝医療機関単位、要再請求）/ L2（2000番台＝レセプト単位、要再請求）/ L3（3000番台＝要確認）/ L4・L48（4000・4800番台＝要確認・正常処理）。「Ssk 受付不能ASP」欄に「●」があるものは医療機関の修正必須。歯科特有チェック例：レセプト種別1桁目が「3（歯科）」以外／傷病名部位レコードが1レセプト100件以上／医療機関情報レコードの次がレセプト共通レコードでない、等。Ssk Miyagi-kokuho
- 一覧の掲載場所：オンライン請求システムの「マニュアル▶その他▶受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科）」、または支払基金HP「トップ▶診療報酬の請求支払▶オンライン請求」。上記直リンクからも取得可。

4-2. レセプトデータの確認試験（オンライン確認試験）

- 正式名称は**「レセプトデータの確認試験」**。本請求前にレセプトデータが記録条件仕様等に適合しているかを確認する仕組みで、**確認試験可能期間内なら何回でも実施でき、前月診療分までのレセプトデータを対象にできる**（[Osakakokuhoren](#) 出典：支払基金/国保連合会「オンライン請求システム操作手順書」第10章「レセプトデータの確認試験を実施する」）。**確認試験のため実際には請求されない／支払基金のみ提供**。エラーメッセージは受付・事務点検ASP結果リストと同じコード体系（「受付処理結果リスト、受付・事務点検ASP結果リスト及びオンライン確認試験結果リストに出力されるメッセージ」Ssk Ssk と各一覧に明記）。

4-3. 国保中央会側の同種ツール

- 国民健康保険中央会も同じオンライン請求システム基盤を共用し、「受付・事務点検ASP」「確認試験」を提供。****ベンダー向けには「レセプト電算処理システムに係る接続試験実施要領（歯科）」（PDF約594KB）と「光ディスクを用いた費用の請求に係る接続試験依頼書**

（歯科）」**を公開（`Kokuho` `kokuho.or.jp/system/resept/`）。チェック一覧（歯科）は国保連合会版も各県サイトに掲示（例：宮城県国保連 令和4年5月版）。

4-4. ORCA（参照実装）

- 日医標準レセプトソフト（日レセ/ORCA, Online Receipt Computer Advantage）。日本医師会が2002年から「日医オープンソース使用許諾契約」に則りプログラムを無償公開している `Med` オープンソースのレセコンで、レセプト電算（レセ電）データ出力機能を標準装備。歯科版もある。UKE出力の挙動を比較する参照実装として有用だが、周辺サービス（マスタ更新・サポート等）は商用版契約が前提な点に注意。ソースとマニュアル類は `orca.med.or.jp` および FTP（`ftp.orca.med.or.jp`）から入手可能。

5. テストデータ作成に役立つ公開資料

- 支払基金 接続試験用サンプルレセプトデータ：再審査等請求の接続試験用に「令和6年6月診療分 歯科:16件（ZIP:754KB）」を配布。「サンプルデータは、架空の医療機関（薬局）コード、患者名等を用いて作成しております」（掲載：`ssk.or.jp/seikyushiharai/rezept/hokenja/download/index.html`、および「レセプト電子データ提供事業 `jigyonaio_03`」）。※これは再審査等請求フォーマットのサンプルである点に留意（一次請求UKEそのものではないが、レコード構造の実例として有用）。
- 受付・事務点検ASPに係るチェック一覧（歯科）令和6年11月版：出力が満たすべき検証条件の網羅一覧（§4-1）。
- チェックロジック（歯科）令和6年7月版：レコード順序・項目別の判定条件（§4-1）。
- 厚労省「診療報酬情報提供サービス」（`shinryohoshu.mhlw.go.jp`）：歯科診療行為・傷病名・歯式・修飾語等の基本マスターCSV。コード存在チェックの突合元に使える。

6. uke-examples.md を自作する際の手順提案

転記元はあくまで `jiki_s01.pdf`（著作権配慮のため逐語長文転記は避け、自分のテストデータとして再構成する）。推奨順：

- 骨格を確定：手引きの「3 ○○レコード記録例」を `p2`→`p4`→`p9`→`p14`→`p16`→`p19` の順に確認し、1レセプトのヘッダ部 `UK` → `IR` → `RE` → `HO` →（公費があれば `KO`）→（資格確認 `SN`／受診日 `JD`／窓口負担 `MF`：令和8年仕様で必要なら） の並びを固める。
- 傷病名部位：第8部 `p27` の記録例で `HS`（歯式コード6桁・配列順）を確認し追加。
- 診療行為を症例別に積む：
 - (a)初診＋充填 ... `p79`（初診 識別11）→ `p117`（修復・補綴 識別61）。`SS` に加算コードを同一レコード内へ。
 - (b)歯周治療 ... `p102`（検査）→ `p104`～（処置）。歯式は `CO` で付与。
 - (c)補綴 ... `p117`～`129`。`SS` + `TO`（特定器材）+ `CO`。
 - (d)公費併用 ... `p16`～`17`の記録順、負担区分は `p68`。
- 末尾に診療報酬請求書：`p139` を見て `GO` を医療機関単位データの最後に必ず1件。
- ファイル物理仕様（記録条件仕様準拠、出力エンジンで最重要）：
 - 文字コードはシフトJIS（JIS X 0208附属書1のシフト符号化表現）。全角カタカナの長音「ー」は文字コード `815b`、ダッシュ `815c`・マイナス `817c` は使用不可。 `ssk` `Mhlw`
 - レコードは可変長・コンマ（,）区切り。各レコード末尾に改行コード。 `ssk`
 - ファイル最終レコードの最終部分は「改行コードの後にEOFコード（1バイト）」を記録する（ `ssk` 記録条件仕様の共通規定。医科・DPCと同一の規定であり歯科も準拠）。
 - 固定長項目は最大バイトまで記録必須、可変長項目は有効桁まででよい。 `ssk`
- 検証：作ったファイルを §4-1/4-2 のチェック一覧（歯科）の各エラー条件に手で当て、特に「レセプト種別1桁目=3」「HSが100件未満」「医療機関情報→レセプト共通の順序」「保険者/公費レコードがレセプト種別に必要数あるか」をゴールデンの `assert` に落とす。可能なら確認試験で実機検証。

Recommendations（段階的アクション）

1. **今すぐ**：表§1の#1～#3（jiki_s01.pdf・チェッカー覧歯科・チェックロジック歯科）をダウンロード。#1で記録例パターン、#2/#3で「正/不正の判定条件」を取得し、ゴールデンテストの期待値とアサーションを分けて設計する。
2. **記録例の写経**：§2-3の症例別ページ（p79/p102/p104/p117/p16）から最小4ケースを自作データとして再構成。^{HS} 識別子（歯科はHS≠SY）と「歯式はSSでなくCO」を実装で必ず分岐させる。
3. **物理仕様の自動チェック化**：シフトJIS・コンマ区切り・改行・**末尾EOFコード**をエンコードのユニットテストに固定化。長音/ダッシュ/マイナスのコード差はカナ氏名テストで検証。
4. **実機検証**：本番前にオンライン確認試験（前月診療分対象、何回でも可）でL1/L2エラーゼロを確認。
5. **版の整合**：手引き（令和6年4月仕様ベース）とユーザー保有の記録条件仕様（令和8年6月版）の差分を洗い、令和8年6月で変わった項目は**記録条件仕様を正**として手引き例を上書きする。

判断を変える閾値：(a) 支払基金が「電子レセプトの作成手引き -歯科-」の令和8年版を新規公開したら#1を差し替える（掲載ページ `iryokikan_02.html` を定期確認）。(b) 確認試験で未知のL2エラーが出たら、対応するチェッカー覧（歯科）の最新版（現行：令和6年11月版）に更新があるか確認する。

Caveats（確認できなかった点・留保）

- **手引きの版整合**：jiki_s01.pdf（令和6年9月版）は記録条件仕様「令和6年4月版」準拠。ユーザー保有の令和8年6月版との差分は本手引きに未反映の可能性。手引き例の逐語を**令和8年仕様の正解**として鵜呑みにしないこと。
- **手引きのファイルサイズ・総ページ数**：サイズは掲載ページ表示で約3,525KB。総ページ数は本文ノンプルで別表まで約142ページ+別紙（目次より p142「別表」）。**正確な総ページ数はPDFを開いて要確認**。ページ番号はすべて**PDF目次ベース**（本文ノンプル）であり、PDFビューアの通しページとは数ページずれる場合がある。
- **傷病名部位レコードの識別子**：歯科は「HS」が正（手引き・記録条件仕様で一貫）。ただしレセ電コード情報ファイル（rezept11.pdf）の構造表に医科テンプレート由来とみられる「SY」表記の不整合が混在するとの調査結果あり。**実フォーマットはHSが正だが**、両資料を突合のうえ最終確認を推奨。
- **歯式コードの定義**：「歯種4桁+状態1桁+部分1桁=6桁」と、別表15～17が「削除」され「別に定める歯式コード（6バイト）」に一本化されたとの情報が併存。**マスターファイル仕様説明書の歯式マスターと記録条件仕様（令和8年6月版）で最終確定すること**。
- ****接続試験サンプル（歯科16件）****は再審査等請求フォーマットのサンプルであり、一次請求UKEとはファイル構成（履歴管理ブロック等）が異なる。一次請求の構造例は手引きの記録例を主とすること。
- **rezept11.pdfの版**：本文は「令和6年6月版」だが、掲載ページでは記録条件仕様として令和8年6月版が最新案内。レセ電コード情報ファイルの令和8年版の有無は**要確認**。